Lucio Cottini

# L'autodeterminazione nelle persone con disabilità

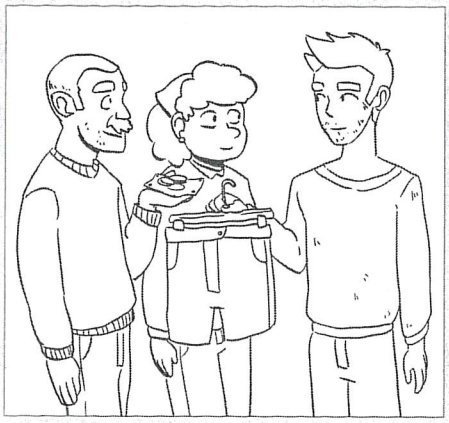
## Percorsi educativi per svilupparla

*i*GUIDE

Erickson

Al centro hanno progettato un programma finalizzato al potenziamento dell'autodeterminazione e anche a casa i genitori cercano di offrire un ampio ventaglio di opportunità.

Oggi sono usciti per andare a fare spese in un grande magazzino e l'obiettivo è di fare acquisti con Enea e non semplicemente per Enea. Il papà mostra che ci sono 50 euro da spendere per comprare alcuni indumenti. Cominciano dalle calze, che Enea sceglie fra parecchie paia diverse per colore. La mamma fornisce alcuni consigli legati alla tipologia di tessuto (cotone, lana), ma lascia libero Enea di individuare il colore preferito. Si va alla cassa a pagare e si continua con l'acquisto di una tuta con il denaro rimasto. Stessa operazione di selezione da parte di Enea, considerando anche i costi in relazione al fondo residuo. Il papà dà indicazioni in questo senso. Dopo il pagamento della tuta rimane un po' di denaro sufficiente per comperare una cuffia.



## La politica dei sostegni

A più riprese durante il lavoro ho sottolineato come l'assunzione di condotte autodeterminate non richieda necessariamente alla persona di essere autonoma nello svolgimento di tutte le funzioni connesse. Può semplicemente indicare i propri desideri e le scelte personali, in modo che si attivi poi un'adeguata organizzazione dei sostegni, per consentire quelle iniziative non supportate da abilità personali consolidate. Ma qual è il giusto livello di aiuto da prevedere al fine di permettere la messa in atto dei piani e degli obiettivi personali?

Ritengo assolutamente strategico pianificare forme di sostegno flessibile, nel senso che l'azione dell'educatore e delle altre figure deve essere modulata sulla base del feedback che fornisce l'individuo con disabilità mentre è impegnato nelle proprie attività. A questo proposito è necessario recuperare l'approccio suggerito da Vygotskij (1978) per un lavoro all'interno dell'*area di sviluppo prossimale,* che richiede un'adeguata quantità di sostegno, perché eccedere porta al rischio di sostituirsi completamente alla persona, inibendo così la sua motivazione e svilendo il senso dell'apprendimento finalizzato all'autodeterminazione.

Wood, Bruner e Ross (1976) hanno utilizzato, per delineare questo concetto, il termine *scaffolding* (creare un'impalcatura), per significare il sostegno fornito da chi è più esperto (genitori, insegnanti, educatori, operatori sociali, compagni, ecc.), che orienta senza dirigere e che aiuta a risolvere un problema e ad appropriarsi di nuovi strumenti cognitivi, in modo da ridurre il divario tra il livello della competenza personale e le richieste dell'ambiente per soddisfare le proprie esigenze.

Per dare un senso meno vago al concetto di «adeguata quantità di sostegno» penso sia utile anche il riferimento a uno strumento di valutazione denominato *Supports Intensity Scale* (SIS; Thompson et. al., 2004). Si tratta di una scala attraverso la quale è possibile appurare l'entità dei sostegni di cui le persone hanno bisogno per intraprendere attività adatte alla loro età cronologica, in ambienti comunitari conformi ai loro bisogni e alle loro esigenze. Esiste anche una standardizzazione italiana della SIS (Cottini et al., 2008), con norme ricavate da un ampio studio su un campione comprendente anche persone con disabilità intellettiva grave e autismo.

Oltre alla quantità di sostegno da prevedere, grande importanza è rivestita anche dall'individuazione di chi fornisce tale supporto alle persone con disabilità e dalle modalità di erogazione dello stesso. Ritengo sia fondamentale, a questo livello, sollecitare una modifica concettuale ancora poco praticata quando ci si riferisce a persone con disabilità intellettiva grave e con autismo. In concreto, l'approccio tradizionale prevede, in tutti gli ambienti, figure specifiche alle quali delegare il compito di sostenere gli individui per le varie esigenze, da quelle più prettamente assistenziali, a quelle ricreative, di apprendimento e sociali.

Anche se alcuni soggetti necessitano effettivamente di assistenza personale di elevata intensità, il ruolo dell'operatore esclusivo e dedicato è da considerarsi troppo limitato per poter soddisfare pienamente le esigenze degli individui, i quali hanno dimostrato bisogni di sostegno molto vari, che non possono essere ignorati (Luckasson et al., 2002). Appare ormai evidente che le persone con disabilità, anche di grave entità, hanno necessità di *reti di sostegno* composte da

diversi soggetti che forniscono molteplici e differenti tipi di supporto. Benché i sostegni naturali — ovvero quelli inerenti all'ambiente, promossi da colleghi di lavoro, vicini di casa, compagni di scuola, autisti dei mezzi pubblici, ecc. — possano non essere sufficienti a fornire tutta la gamma di aiuti indispensabili a molte persone, una vera inclusione all'interno della società non sarà raggiungibile fino a quando l'offerta di sostegno rimarrà unicamente, o quasi, a carico di figure dedicate a questo scopo. Si tratta di quella forma di sostegno diffuso sul quale si è concentrato a più riprese anche Canevaro (2011).

Il nuovo paradigma dei sostegni (Thompson et al., 2004) e l'adozione di una visione della disabilità che si riferisce anche a un modello sociale (Cottini, 2014b), sposta l'attenzione dal «prendersi cura dell'individuo con i suoi deficit», all'investire tempo e impegno per promuovere reti di sostegno in qualsiasi ambiente nel quale la persona voglia o abbia la necessità di stare. Questo, chiaramente, non significa eliminare il ruolo degli operatori specializzati, che rimane sempre centrale e strategico, ma integrarlo con forme di sostegno più naturali, fornite da chi vive nell'ambiente della persona con disabilità, in un modo che non sia né troppo invadente per chi ne usufruisce, né troppo vincolante in termini di tempo e impegno per chi lo fornisce.